Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Camilo Andres Silva Vidal					Sexo	F		M X
Fecha Nacimiento	29-10-2020	Edad actual	5 años	5 meses	País natal:	Chile			
Domicilio actual:	Av. Segunda costanera 16241 Los Andes.				Teléfono	968739268			
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende X	habla X	lee ☐	escribe ☐			
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende X	habla X	lee ☐	escribe ☐			
Escolaridad actual:	Kinder A	Establecimiento	Liceo Delicto Pastor N°2						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	11-03-2026	2. Fecha de la entrevista:	
Nombre:	Ana Vidal	Nombre:	
Relación con el/la estudiante:	Madre.	Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	
3. Fecha de la entrevista:		4. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Relación con el/la estudiante:		Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	11-03-2026	2. Fecha de la entrevista:	
Nombre:	Gabriela Landaeta A	Nombre:	
Rol/cargo:	ED. Diferencial	Rol/cargo:	
3. Fecha de la entrevista:		3. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Rol/cargo:		Rol/cargo:	

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Cambio diagnóstico de TL (P-K) a TEA, Clasificación según elaboración ADOS-2.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología: En PK estuvo con el diagnóstico de TL recibiendo apoyos x pab sobre Tumy Tot.	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: X	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro: X ED. Diferencial.

5.1. Primer año de vida		
Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) 39 semanas programada		
Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☒ NO	Peso: 3,050	Talla: 48
Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto: Diabetes gestacional s/t mes.		

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	No	Traumatismos	Sí	No	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	No	Intoxicación	Sí	No	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	No	Enfermedad respiratoria	Sí	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	No	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					
Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No		Vacunas			Sí	No

Observaciones:
Cuando nació permaneció 3 días por su color amarillo.
15 días hospitalizado a los 6 meses x sangrado interno.
Diagnostico de Hemofilia severa. Tratamiento que x medio. Lunes - miercoles - viernes.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6m	Se sienta sólo/a: 9m	Camina sin apoyo: 1a, 9m
Primeras palabras: 2a (apoyo)	Primeras frases: a los 3 años	Se viste solo/a: la mamá ayuda.
Controla esfínter vesical Diurno: _____ Nocturno: 3 años	Controla esfínter anal Diurno: _____	Nocturno: 3 años

Observaciones:
- Su desarrollo fue más tardío.

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☐ activo ☒ hiperactivo ☐ hipoactivo
A veces

Su tono muscular general se aprecia: A veces se cae el piecal caminar.
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	No	Caídas frecuentes	Sí	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí	No	Prensión	Sí	No	Pinza	Sí	No
Ensarta	Sí	No	Dibuja	Sí	No	Escribe mozo.	Sí	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Sí	No	Manipula y Explora objetos	Sí	No
Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No

Observaciones:

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.) A veces le molestan los ruidos.	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): No.

Observaciones:
A comenza a hablar a los 3 años (a finales de este año)

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa (cmayuda de la mamá)	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es: Se asusta muy rapido, cuando no sabe lo que pasa.

Luces: A veces. ☐ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** Ruidos fuertes ☒ natural ☐ desmesurada le molestan.	**Personas extrañas:** ☐ natural ☐ desmesurada es muy amistoso.

Observaciones:

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique): * Hemofilia severa		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
→ Enfermedad que fue detectada al nacer, su mamá es portadora igual que su abuelo paterno.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 HRS.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☒ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro: De repente

Observaciones:

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Ana Vidal	mamá	35	4° medio	D. de casa.
2. Cristina Silva	Hermana	10	colegio	4° básico.
3. Cristobal Silva	Hermano	11	colegio	7mo básico.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Hermano D-K y K en escuela lenguaje.
Fue tardio su desarrollo como en lenguaje.

Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	Sí	No X
Nº de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular X Especial ☐ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios:				

Ha repetido curso/s	Sí	No X	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	KA		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No ✓	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as) en el colegio	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☐ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- Vivían antes en San Bernardo santiago.
- X cambiaron el año 2024 a los Andes.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY